

Isolement social chez les personnes âgées institutionnalisées

Travail de fin d'études présenté

Pour l'obtention du grade académique de

Bachelier : Infirmier Responsable de soins généraux

Par

SIMON Margot

Juin 2022

Remerciements

Je souhaite tout d'abord exprimer toute ma reconnaissance à Madame Zekri dont la disponibilité sans faille, les conseils avisés, les critiques constructives ainsi que l'aide dans l'élaboration de ce travail, ont été très précieux.

J'adresse également mes plus sincères remerciements à la personne interviewée qui a accepté de répondre à mes questions avec sincérité et bienveillance. La richesse de cet échange a nourri ma réflexion. De plus, il a conféré une dimension humaine à ce travail.

Une énorme pensée pour mes parents dont le soutien et l'amour indéfectibles m'ont portée tout au long de ce travail et de mon existence. Leur aide dans les recherches et la relecture qu'ils ont patiemment accomplis tout au long de ces quatre années.

À ma marraine et mon parrain qui ont effectué bon nombre de lectures et de relectures sans jamais faillir, toujours avec humour et tendresse.

Je tiens à témoigner toute ma reconnaissance à Isa pour son aide. Sa relecture et ses remarques ont été d'une grande qualité.

Un remerciement particulier à la Haute École Robert Schuman Département Paramédical de Libramont et à l'ensemble de mes professeurs qui m'ont dispensé leurs connaissances et leurs pratiques. Ils m'ont aidée à devenir la future professionnelle qui a le plaisir de vous présenter ce travail.

Je tiens à remercier les membres de ce jury pour le temps consacré à la lecture de ce travail.

Je souhaite dédier ce travail à ma grand-mère dont l'affection, la tendresse et la présence, ont toujours beaucoup compté.

Mots- clés :

- Communication
- Isolement social
- Personnes âgées

Table des matières

INTRODUCTION	5
1. CONSTAT(S), INTERPELLATION(S) ET ANCRAGE A LA DISCIPLINE INFIRMIERE	6
1.1. CONSTATS	6
1.1.1. <i>Première situation</i>	6
1.1.2. <i>Deuxième situation</i>	7
1.2. INTERPELLATION.....	8
1.3. ANCRAGE	9
2. RECHERCHES ET REFLEXION PROFESSIONNALISANTE	13
2.1. EXPLORATION DES CONCEPTS.....	13
2.1.1. <i>Altération de la communication</i>	13
2.1.2. <i>Isolement social</i>	17
2.2. ANALYSE DE L'ENTRETIEN EXPLORATOIRE	21
2.3. RECHERCHE ET ANALYSE D'UN ARTICLE PROBANT	25
3. SYNTHESE, QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET PISTES DE REFLEXION	29
CONCLUSION PERSONNELLE	32
LISTE DE REFERENCES.....	33

Introduction

La thématique de ce travail de fin d'étude (TFE) s'est imposée à moi comme une évidence tant par certaines expériences vécues lors de mes stages que par une situation familiale qui me préoccupe, celle de ma grand-mère maternelle. En effet, lorsque je revenais de stage, j'interpellais régulièrement mes proches quant à la difficulté d'institutionnaliser nos personnes âgées. Ma grand-mère est encore issue d'une génération où l'on gardait ses parents à domicile et pour beaucoup de personnes âgées, ce placement est souvent très mal vécu. Ce sujet qui semble tabou et sensible au point de pouvoir susciter des disputes, génère des sentiments d'abandon et de culpabilité. On recule l'échéance jusqu'à ce que celle-ci devienne une urgence indiscutable. La situation exceptionnelle de la pandémie a mis en avant ces notions d'isolement social et de sentiments de solitude.

Lorsque le moment, tant attendu, du choix de TFE arrive, réaliser une rétrospection des années passées au cours de ce cursus, m'a semblé tout naturel. Les différents stages qui ont jalonné ces années d'études, m'ont permis d'évoluer et d'être la personne que je suis aujourd'hui.

Certaines situations ont été plus marquantes que d'autres et sont à l'origine de mes interpellations. J'ai donc décidé de les mettre comme point de départ de ma réflexion et de développer deux concepts de base qui y sont liés ; **l'altération de la communication et l'isolement social**. Dans ce cadre, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec une professionnelle qui travaille en maison de repos et de soins (MRS). Cette rencontre et mes lectures ont fait progresser ma réflexion sur le sujet et cette diversité de références me permet de proposer une analyse plus nuancée sur cette thématique.

1. Constat(s), interpellation(s) et ancrage à la discipline infirmière

1.1. Constats

Lors de mes stages, deux situations vécues ont particulièrement retenu mon attention.

1.1.1. Première situation

Au cours de mon stage de première année, j'ai dû effectuer une aide alimentaire auprès de Madame D. À cette époque pré-Covid, les résidents prenaient leur repas dans le réfectoire, sauf exception. Madame D était en fauteuil roulant, à table avec trois autres dames dont une qui ne voulait pas manger seule. Les deux autres se portaient relativement bien. À ce moment-là, ne sachant pas encore que Madame D avait été victime d'un AVC, je n'en réalisais pas vraiment les séquelles. Je me suis assise en face d'elle et je me suis présentée. Je lui ai expliqué mon statut de stagiaire de première année d'infirmière et je l'ai informée que j'allais l'aider à s'alimenter. Elle m'a regardée et observée. Je pense qu'elle était contente de découvrir un nouveau visage.

Avant de commencer à lui donner son repas, j'ai vérifié que son alimentation était totalement mixée. Pendant ce temps, elle a essayé de me parler en émettant des sons. Le peu de mots que j'ai perçus ne suffisaient pas à me permettre de deviner le sens de ses phrases. J'avais beau lui demander de répéter en la regardant dans les yeux, je ne parvenais pas à la comprendre. Après tant d'efforts, je pense qu'elle s'était résignée. Elle a baissé les yeux vers son assiette et elle a commencé à manger. J'étais complètement désespérée face à son expression. J'ai demandé à plusieurs membres du personnel soignant de m'aider à la comprendre. Finalement, personne n'y arrivait et chacun a poursuivi son occupation. Je me suis sentie seule, triste, impuissante et mal à l'aise face à cette dame. J'ai terminé de lui donner son repas tout en essayant de la comprendre car établir une communication, aussi simple soit-elle, était important pour moi.

Face à l'échec de nos échanges, j'ai eu le sentiment que cette dame devait se sentir très isolée. À ce moment, la patiente s'est trouvée seule avec ses pensées et elle ne pouvait les partager avec moi de quelque manière que ce soit. La jeune élève novice que j'étais, n'a pas eu le réflexe de demander à consulter le dossier infirmier afin de trouver les diverses informations qui auraient pu m'aider à comprendre la situation de Madame D.

1.1.2. Deuxième situation

En mai 2020, lors de ma seconde année de formation, je suis retournée dans cette MRS. De nombreuses choses avaient changé. Nous étions dans la première vague de la pandémie de la Covid-19, mais heureusement, l'établissement ne comptait personne de positif.

J'ai rencontré une résidente qui vivait dans ce home depuis un certain temps. Elle était encore très lucide et aimait discuter. J'ai souvent pris le temps d'échanger avec cette personne lors de la toilette du matin ou avant la mise au lit. Elle parlait principalement de sa vie au sein du home et de ses difficultés d'adaptation. L'entrée dans le home et la coupure sociale avec son ancienne vie, son entourage amical et son environnement habituel, ont été pour elle les premiers pas vers l'isolement. Toutefois, ses enfants ne l'ont jamais abandonnée et la soutenaient par de nombreuses visites.

Madame T était veuve depuis une dizaine d'années, elle avait trois enfants et cinq petits enfants avec qui elle entretenait de très bonnes relations.

Elle avait trouvé un nouvel équilibre et de nouvelles habitudes grâce aux repas pris dans le réfectoire, aux discussions avec les autres résidents et à ses balades aux alentours de la résidence qui lui faisaient du bien au moral. J'ai pu ressentir à travers ses récits toute la joie qu'elle éprouvait lorsqu'elle repensait à ces moments de gaieté.

Malheureusement, suite à la pandémie, les visites étaient interdites. Les résidents ne pouvaient plus descendre manger au réfectoire, ils mangeaient tous en chambre, seuls. De plus, les activités organisées habituellement étaient annulées. Madame T m'a alors confié qu'elle se sentait fort seule et qu'elle n'avait pas le moral depuis qu'elle ne voyait plus sa famille ni les autres résidents. La pandémie lui avait pris le peu de relations sociales qui lui restait et le personnel soignant était son unique lien. Heureusement, le téléphone a permis de maintenir le contact avec sa famille. Mais pour elle, rien ne pouvait remplacer la proximité physique. Je me suis sentie impuissante face à la détresse de Madame T. Bien qu'elle appréciait que je vienne discuter avec elle quand j'en avais l'occasion, le manque de sa famille et de ses connaissances était très présent.

Dans son cas, la pandémie a créé un nouvel isolement au sein de l'environnement qu'elle avait réussi à se construire grâce aux liens sociaux tissés avec les autres résidents et le personnel soignant. Ceci est un exemple d'isolement provoqué par le manque de contacts sociaux. Contrairement à mon premier constat, la cause de l'isolement n'était pas en lien direct avec une

pathologie mais bien avec des mesures imposées qui ont réduit les possibilités de communication des personnes âgées.

Par la suite, j'ai été engagée dans ce home lors des vacances d'été 2020 en tant que jobiste. Durant ce creux de contamination, l'établissement avait organisé des visites d'une quinzaine de minutes afin que les familles puissent venir voir leurs proches. Plusieurs alternatives ont été proposées. Le plexiglas a été la solution choisie pour permettre les rencontres, tout en gardant un espace de sécurité propre à chacun. Cependant, le résultat n'a pas eu l'effet escompté. En effet, il était très difficile pour les personnes d'entendre leur interlocuteur. C'est pourquoi, le personnel a mis à leur disposition, des téléphones placés de part et d'autre de ce plexiglas afin que la conversation soit plus audible. Néanmoins, ce moyen n'était pas toujours efficace et restait une entrave à la communication. De plus, ces différentes installations ne permettaient pas aux résidents malentendants, malvoyants ou désorientés d'établir un dialogue ou un échange valable avec leurs proches. Une autre solution pour les familles a été de déposer des affaires personnelles tels que des vêtements, des chocolats, des friandises, des magazines, ... afin d'apporter du réconfort, de monter leur affection et leur soutien. Tout objet transmis, était mis en quarantaine durant 48 heures avant d'être donné aux résidents.

1.2. Interpellation

L'isolement dont souffraient certains résidents, m'a touchée lors de ces différentes expériences.

Madame T avait déjà vécu une première expérience d'isolement, provoquée par l'entrée en institution. Le fait de quitter sa maison et de perdre ses habitudes sociales, ont été des événements difficiles à intégrer pour la résidente. J'ai pris conscience que les personnes âgées subissent les conséquences d'une perte d'autonomie dans une société qui ne permet plus aux familles de garder leurs aînés au sein de leur domicile. J'avais le sentiment qu'elles ne voulaient pas être un fardeau d'une part mais qu'ils n'acceptaient pas ce déracinement d'autre part. En outre, la pandémie n'a fait que renforcer cet isolement. À ce moment-là, nous n'avions que peu de connaissances quant à la propagation du virus. Le gouvernement a priorisé la santé publique au détriment du bien-être psychologique.

Chez Madame D, ce ressenti de solitude était dû à un trouble de la communication. À l'époque, je n'avais ni l'expérience ni la connaissance pour me référer à des moyens de communication. Je n'avais donc pas les outils nécessaires pour que Madame D puisse s'exprimer et se faire

comprendre. Je ne me suis donc pas sentie armée pour faire face à cette réalité. Ce sentiment d'impuissance m'a vraiment déstabilisée.

Lors de ces deux expériences, j'ai pu observer que les personnes âgées institutionnalisées peuvent être confrontées à une grande solitude et à un isolement social. Ceux-ci peuvent être consécutifs à une limitation de la communication dont l'origine est soit l'émergence d'une pathologie, soit des événements extérieurs. C'est ce qui a motivé le sujet de mon TFE.

1.3. Ancrage

Il existe des décrets, des lois, des chartes, ... qui luttent contre l'isolement des personnes âgées. Cependant, certains sont difficilement applicables. Nous les relèverons tout au long de ce travail, lors de l'entretien avec une professionnelle de terrain ainsi que dans l'analyse de l'article probant.

La première étape de l'isolement en institution se produit dès que le choix du placement se décide. Selon le Décret relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées dans l'article 6 §1^{er} 2° : « La programmation des établissements [...] a pour objectif d'assurer une répartition homogène des établissements pour personnes âgées sur l'ensemble du territoire de la Région Wallonne afin de garantir une proximité géographique permettant le maintien des liens sociaux existants » (Parlement Wallon, 2009, p.4). Il est vrai qu'entrer dans une maison de repos à proximité de sa famille permet des visites plus fréquentes. Ces dernières adoucissent le quotidien et permettent une adaptation plus facile. Généralement, le choix de la maison de repos dépend de nombreux paramètres. Ceux-ci peuvent être financiers, basés sur la bonne entente des enfants, dépendant d'un choix pris précédemment par le résident et son (ses) enfant(s), d'une pathologie éventuelle, du lieu initial de vie (Bruxelles est différent d'Arlon), ...

Ensuite, au sein de ce même décret, l'article 10 §1^{er} 10° a) définit

les dispositions relatives à l'accueil des résidents prises dans le but de respecter leur personnalité, d'apaiser le sentiment de rupture éprouvé par eux et leur famille lors de l'entrée et de déceler les éléments qui permettront, au cours du séjour, de mettre en valeur leurs aptitudes et leurs aspirations (Parlement Wallon, 2009, p.8).

Effectivement, l'entrée en maison de repos peut être ressentie comme une rupture avec son ancienne vie. Cette entrée n'est malheureusement pas toujours facile pour le résident. Pour certains, les moyens pour exprimer leur mécontentement, est le rejet des autres, le repli sur soi, le syndrome de glissement, etc. Pour les personnes désorientées ou ayant un début de démence,

ce changement de vie est parfois mal vécu et peut aussi accentuer la confusion. Le temps d'adaptation est parfois plus long.

Concernant la mobilité, l'article 4-8 de la Charte Européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées nécessitant des soins et une assistance de longue durée (Union Européenne, 2010, p.13), stipule que le patient a « le droit de recevoir une aide et des interventions visant à stimuler sa mobilité. » Le droit à la mobilité doit être garanti par l'institution. En effet, l'établissement doit mettre en place des moyens en termes de matériels et de soins qui maximisent le maintien de la mobilité des résidents. Cet espace de déplacement n'est pas limité à la chambre mais il inclut l'ensemble de l'établissement. Cependant, de façon concrète, j'ai pu observer que la plupart des résidents restent spontanément dans leur chambre. Peu de patients prennent l'initiative de circuler dans l'établissement. C'est l'une des causes de l'isolement. Idéalement, les déplacements devraient être accompagnés soit par la famille soit par les soignants. Les membres du personnel veillent à accompagner les résidents dès qu'ils le peuvent.

De plus, l'article 10 §1^{er} 8° d) du Décret relatif à l'hébergement et l'accueil des personnes âgées (Parlement Wallon, 2009, p.7) fait référence à « la plus grande liberté possible de sortie ». Concernant les sorties à l'extérieur de l'établissement, les résidents sont libres d'en faire. Le manque de mobilité peut être un frein, c'est pourquoi favoriser les déplacements au sein de l'implantation doit être maintenu et encouragé.

Tel qu'énoncé dans l'article 10§1^{er} 10° b) du Décret relatif à l'hébergement et l'accueil des personnes âgées (Parlement Wallon, 2009, p.8), il existe une autre façon de :

... permettre aux résidents de trouver un cadre de vie aussi proche que possible de leur cadre familial, notamment en encourageant leur participation aux décisions concernant la vie communautaire et en développant des activités occupationnelles, relationnelles, culturelles en vue de susciter l'ouverture de la maison de repos vers l'extérieur ;

J'ai aperçu des photos montrant des enfants d'écoles venus faire des bricolages dans le cadre des rencontres intergénérationnelles. Ils ont apporté vie et gaieté dans le home. J'ai aussi assisté à un concert de musique classique joué devant l'établissement. Les résidents ont beaucoup apprécié ce moment culturel. Les institutions ont également pour fonction d'être un lieu où les personnes extérieures peuvent se rendre pour rencontrer leurs aînés. On pallie ainsi à leurs difficultés de mobilité qui s'accroissent avec le temps. Cela permet de maintenir un lien avec la société.

Au début de mon cursus scolaire, nous avons reçu le Référentiel de Compétences Professionnelles du Bachelier : Infirmier Responsable de Soins Généraux. J'ai relevé la compétence 5.3. a) « Établir une relation de confiance » (Haute École Robert Schuman [HERS], 2018 – 2019, p.17). Cette compétence est en lien avec ma thématique car pour moi, elle est primordiale. Mettre cette capacité dans les compétences de base à acquérir est indispensable et a pris sens lors de mes expériences en home. En effet, établir une relation de confiance, oblige l'infirmière à ne pas se cantonner à un rôle de soignant. Une confiance sur laquelle peut se développer une relation doit être incluse dans le champ de compétences de l'établissement. Le manque de relation est un terrain favorable à l'isolement. Sans cela, le patient ne peut se confier sur ses sentiments, son ressenti ou ses craintes. Lors de la situation avec Madame T, j'ai pu instaurer cette relation de confiance en pratiquant l'écoute active. Je lui ai posé des questions afin de lui montrer que je m'intéressais à elle, à sa situation, à ses préoccupations et à sa famille. Si je n'avais pas réussi à instaurer une relation de confiance avec Madame T, elle ne m'aurait probablement pas confié sa tristesse de ne pas voir ses proches et son énervement suite aux mesures sanitaires. Créer une relation ne dépend pas uniquement de la bonne volonté ni des compétences du soignant. Une relation implique deux personnes, deux personnalités qui peuvent ou pas se rencontrer. Il n'est donc pas toujours possible de l'appliquer avec chaque résident. Avec Madame D, le manque d'échange verbal m'a bloquée et mon manque d'expérience ne m'a pas permis de contourner le problème, je me suis focalisée sur ce manque de parole et je n'ai pas pu rebondir en utilisant la communication non-verbale pour m'aider à créer cette relation de confiance.

Selon l'article 6-2 de la Charte Européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées nécessitant des soins et une assistance de longue durée, le patient a « droit à toute l'aide nécessaire pour lui permettre de communiquer » (Union Européenne, 2010, p.16). Cette communication est importante afin de pouvoir créer une relation. Heureusement, Madame T savait communiquer sans difficulté, alors que Madame D ne pouvait entrer en relation que par le non-verbal.

Selon cette même charte, dans l'article 1-2. 5, les patients ont « Droit à la dignité, au bien être psychologique et mental, à la liberté et à la sécurité » (Union Européenne, 2010, p.7) ainsi qu'au droit « D'être protégé(-é) contre toute tentative de vous séparer d'une autre personne auprès de laquelle ils souhaitent être. » (2010, p.7) Lors de la pandémie, ce droit n'a pu être respecté. Néanmoins, l'article 10 -1 déclare que les résidents doivent

... respecter les droits et les besoins des autres personnes qui vivent et travaillent autour d'eux, et respecter l'intérêt général de la communauté au sein de laquelle ils vivent ; leurs droits et leurs libertés ne sont limités que par la nécessité de respect des droits similaires des membres de la communauté (Union Européenne, 2010, p.24).

C'est la raison pour laquelle, lors de la pandémie, les patients ont été isolés. Ils prenaient leur repas seuls dans leur chambre et les activités du home n'étaient plus organisées. Toutes les relations sociales dans l'environnement de l'établissement ont été suspendues. Cette pandémie a conduit à la privation des visites pour garantir la santé au sein de la communauté. Au vu de la situation, le gouvernement a opté pour l'application de la charte qui favorise la santé physique à la santé mentale.

En conclusion, les lois, les décrets, les chartes, ont pour objectif de poser un cadre afin de maintenir une bonne qualité de vie pour nos aînés dans le dernier chapitre de leur vie. Il existe différents types de structures en fonction du niveau d'autonomie du résident. Nous ne sommes malheureusement pas dans un monde idéal et l'application n'est pas toujours optimale. Dès lors, la réalité pourrait-elle être toute autre ?

A ce stade de ma réflexion, deux grands concepts me paraissent évidents : l'altération de la communication et l'isolement social. Ceux-ci seront définis et expliqués dans la suite du développement.

Les premières définitions qui sont présentées sont issues de dictionnaires pour le grand public et par conséquent, ils ne sont pas repris dans ce type de références. Seuls les notions de communication et d'isolement seront mentionnés à ce stade.

Le dictionnaire de poche Larousse définit la communication comme « Être en relation » (2010, p.163). « Le Petit Larousse illustrée » définit l'isolement comme un « État de quelqu'un qui vit isolé ou qui est moralement seul » ou comme la « Séparation d'un individu - ou d'un groupe d'individus - des autres membres de la société. » (2010, p.950).

2. Recherches et réflexion professionnalisante

2.1. Exploration des concepts

L'altération de la communication et l'isolement social sont deux problématiques que l'on peut rencontrer fréquemment au sein d'une population âgée.

2.1.1. Altération de la communication

Dans un premier temps, je m'efforcerai de définir la notion de communication dans sa conception la plus générale. Puis, j'aborderai la notion de la communication verbale altérée. Le Petit Larousse Illustré définit la communication comme : « 1. Action, fait de communiquer, d'établir une relation avec autrui. 2. Action de communiquer, de transmettre qqch à qqn » (2010, p.227). Le « Dictionnaire de psychologie » dit que non seulement, « La communication normale comporte l'établissement d'une liaison informationnelle réciproque entre deux individus ou un individu et un groupe d'individus. » (Perdoncini et Yvon cité par Virel, 1977, p.51) mais également que « La communication doit être un échange et non se limiter à un mouvement unilatéral ; elle entraîne même une évolution dans le comportement des deux partenaires » (Virel, 1977, p. 51). Le langage verbal est constitué de signes verbaux qui nous permettent de transmettre des idées que nous évoquons mentalement. Il est important de ne pas oublier la communication non-verbale qui intervient de façon tout aussi importante que le langage verbal. Le rôle essentiel du non-verbal est de véhiculer des informations affectives, émotionnelles mais il ne permet pas d'apporter une certaine complexité dans le message. Lorsqu'il y a ambiguïté dans le message reçu, le non-verbal est en général plus fiable car il trouve sa source dans la spontanéité et ne peut être manipulé. Il est plus révélateur de la personnalité réelle de l'interlocuteur (Renauld, 2017). « La communication humaine totale utilise ainsi un ensemble d'éléments verbaux et non-verbaux passant par différents canaux » (Cosnier, 1977, p.2034). « La forme du message est donc le facteur qui pèse le plus lourd pour déterminer l'un des aspects les plus importants de la communication : la relation » (Mias, 2003, p.1). Dans le manuel « La communication interpersonnelle » de De Vito, Chassé et Vezeau (2019), il est mis en avant que la communication n'est pas qu'une succession de mots. En effet, c'est un ensemble d'actes, de situations et de paroles qui conduisent à un résultat qui a pour but d'être compris par les deux intervenants. Mon premier constat illustre une communication verbale altérée qui se définit comme suit « Difficulté, retard ou inaptitude à recevoir, à traiter, à transmettre et à utiliser un système de symboles » (Pascal et Frécon Valentin, 2017, p.118).

Pascal et Frécon Valentin déterminent les caractéristiques de la communication verbale altérée. Cependant, cette liste inclut également le non-verbal. À savoir « incapacité de, ou difficulté à utiliser les modes d'expressions corporelles ou faciales » (2017, p. 118). Les spécificités des attributs verbaux sont le « déficit visuel partiel ou total, difficulté à comprendre et maintenir une communication, difficulté à exprimer ses pensées verbalement, difficulté à former des mots » (2017, p.118). Dans le cadre du stage, j'ai pu observer la plupart des attributs cités précédemment au travers du trouble du langage présent chez Madame D. Toutefois, la communication non-verbale était préservée malgré l'hémiplégie et elle utilisait spontanément ce mode car elle était dans une intention de communication. De ce fait, sa déception était visible et perceptible grâce à ce canal et plus précisément son regard.

Une altération de la communication peut trouver son origine dans des causes diverses. Elles peuvent être d'ordre physique telles que les déficits sensoriels qui accompagnent fréquemment l'avancée en âge ou l'accident vasculaire cérébral (AVC) qui est à l'origine du trouble de la communication de Madame D. Je citerai également la maladie d'Alzheimer car elle est la cause la plus fréquente de démence (Organisation Mondiale de la Santé [OMS], 2021). De plus, « les troubles du langage font partie, avec les troubles de la mémoire et les troubles des fonctions exécutives, des premiers signes cliniques cognitifs de la maladie » (Tran et al., 2012, p. 1659). Il me semble également pertinent d'aborder brièvement le sujet de la pandémie que l'on peut référer comme facteur externe à l'altération. En effet, les lois qui en ont résulté, ont eu un impact sur la communication des personnes âgées en institution comme dans le cas de Madame T.

Les déficits sensoriels qui peuvent être consécutifs à l'avancée de l'âge, sont évoqués par Roland Covelet. Il cite « une baisse de la vision, une dégradation de l'audition, une légère altération du goût, une altération de l'odorat, une diminution légère des sensations tactiles » (2007, p.1-2). La vue et l'ouïe, sont les deux sens qui se dégradent le plus avec l'âge. Ils ont, dès lors, un grand impact sur la communication. « Cette dernière est vitale pour l'être humain, qui est avant tout un animal social dont la capacité à faire lien sera compromise s'il voit, et surtout entend, mal » (Covelet, 2007, p.6).

Seconde origine de cette altération, l'AVC qui est mentionné par Tristan Cudennec gériatre comme l'un des premiers facteurs qui provoque le handicap chez l'adulte et l'une des causes principales de la démence. Huit fois sur dix, la nature de l'AVC est ischémique (en opposition avec les hémorragiques) et liée à l'obturation d'une artère cérébrale (2019). La gériatre, Annabelle Castex, explique que la population majoritairement atteinte est celle des plus de 65

ans. L'AVC est donc en corrélation directe avec le vieillissement. La prise en charge précoce et pluridisciplinaire ainsi que le suivi thérapeutique rapide et adéquat, permettent de réduire les risques de mortalité, de handicap et l'apparition de toute nouvelle atteinte cérébrale. Il est important d'effectuer un bilan neurologique qui reprendra les niveaux de compréhension, de communication, de cohérence ainsi que les capacités attentionnelles et les fonctions cognitives globales. Une évaluation de la déglutition ainsi que la présence d'un trouble du langage éventuel, devront être établies (2019). En ce qui concerne le cas de Madame D, la situation vécue s'est déroulée lors d'un stage d'observation active. Dès lors, mon développement se base uniquement sur les constatations faites lors du soin d'aide alimentaire. Madame D présentait une aphasie et une hémiplégie droite résultant d'un AVC. Cela a eu pour conséquence de rendre nos échanges difficiles et a impacté le moment-plaisir que l'on essaye de créer lors de ce soin.

En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, elle se caractérise par une dégradation des troubles neurocognitifs et est la troisième cause que j'évoque en lien avec l'altération de la communication.

Les troubles neurocognitifs ne provoquent pas uniquement une perte ou un désapprentissage du langage. Ce n'est pas la fonction langage qui est impactée, mais les fonctions cognitives – supports nécessaires à la production du langage : mémoire sémantique, mémoire procédurale, mémoire de travail, fonctions exécutives et vitesse de traitement (Haute Autorité de Santé [HAS], 2018, p.1).

Tran et al. (2012), ont mis en évidence qu'une déficience dans l'épreuve de dénomination d'images peut être considérée comme révélatrice d'un trouble précoce dans la production lexicale. Il peut donc être un symptôme pertinent dans la détection de la maladie d'Alzheimer. L'aspect neurodégénératif atteint les compétences sémantiques alors que les versants syntaxiques et phonologiques sont préservés plus longtemps. Cette dégradation atteint aussi bien le concept que le mot. À l'heure actuelle, il est démontré, que les maladies démentielles neurodégénératives sont distinctes des aphasies par lésions focales. Au cours de mes stages en maison de repos, j'ai pu observer des patients atteints de cette maladie invalidante. Il était difficile de communiquer avec eux car leurs phrases et leurs mots n'avaient pas toujours de sens. Il était difficile de comprendre quels étaient leurs réels besoins. La conversation étant bancal, maintenir des échanges sans créer de frustration et de découragement, était compliqué.

Afin d'illustrer la situation de Covid-19 dont les modalités d'éviction mises en place dans le quotidien de tout un chacun, peuvent être assimilées à une cause externe. Le centre interfédéral pour l'égalité des chances Unia a rapporté, je cite :

Les modalités proposées dans le cadre du déconfinement ont fait l'objet de « plaintes » de la part des familles auprès des directions : visites dans une salle collective au vu de tous, sous surveillance, distance, plexiglas, terrasse extérieure aménagée empêchant toute intimité, port du masque obligatoire rendant la communication difficile pour des personnes ayant des problèmes sensoriels. (Unia, 2021, p. 46).

Toutes ces contraintes liées à l'obligation de non-contacts directs, ont eu pour conséquences d'altérer les échanges et ont compromis le bon déroulement de la communication.

Dès lors, des conséquences ont découlé de cette altération. L'une d'elles est une mauvaise transmission dans l'échelle de la douleur que doit établir le patient présentant un trouble de la communication. En effet, Aubin et al. mentionnent dans leur étude qu'ils « s'accordent pour affirmer que la prise en charge de la douleur chronique dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) est sous-optimale » (2007, p.1). En effet, les instruments de mesure de la douleur chez les personnes âgées sont basés sur un retour verbal. Cet aspect est pris en compte par certains outils mais sont non pertinents si on y adjoint un trouble cognitif profond ou une démence. Les troubles sensoriels associés au vieillissement, entraînent une altération de la communication qui a un impact sur la vie sociale des personnes âgées. Clémence Lamirant mentionne un outil d'évaluation spécifique pour les soignants. Les hétéro-évaluations sont un système d'évaluation et d'observation établi par le professionnel. On observe le patient pendant et après un soin où il est susceptible de souffrir. Il existe aussi l'échelle Doloplus 2 validée en gériatrie. Elle se base sur trois groupes de symptômes car ils sont des indicateurs en cas d'apparition de la douleur. Dans ce cas, le somatique, le psychomoteur et le psychosocial. Toutefois, ce travail est l'affaire d'une équipe pluridisciplinaire et non d'un soignant isolé (2010).

Dans le cas de Madame D, j'ai présumé par son manque de communication qu'elle devait se sentir seule et isolée. Cependant, cela reste un ressenti personnel sur sa situation. N'ayant pas pu comprendre ses besoins, je ne peux distinguer ce qui est le résultat de ma frustration ou de son ressenti réel.

Les autres conséquences évoquées par cette altération de la communication sont l'isolement social et le sentiment de solitude. Deux articles serviront de référence afin de les illustrer.

Roland Covelet explique que la dégénérescence progressive de l'audition et/ou de la vision occasionne un manque de sollicitation cognitive et provoque également une diminution de l'attention sur l'environnement. Cela complique les relations sociales, favorise le repli sur soi et la dépression (2007). Mais également, selon Cyril Hazif-Thomas, l'un des facteurs aggravant le sentiment de solitude, est le manque de prise en charge des troubles du langage qui peuvent apparaître. « Solitude également quand les mots manquent ou lorsqu'aucune assistance ne vient aider à rétablir la communication » (2014, p.18).

2.1.2. Isolement social

Ce sujet sera également centré sur la population des personnes âgées.

Pour cerner ce concept d'isolement social, je me suis référée dans un premier temps à la définition fournie dans l'ouvrage « Diagnostics infirmiers, interventions et résultats ». Pascal et Frécon Valentin, expliquent l'isolement social comme une « Expérience de solitude que la personne considère comme imposée par autrui et qu'elle perçoit comme négative ou menaçante. » (2017, p.330). Lorsqu'une personne est isolée socialement, l'une des conséquences est de développer un sentiment de solitude. Cependant, le terme d'isolement social n'est pas repris dans les dictionnaires non spécialisés. « Le Petit Larousse » définit l'isolement comme un « État de quelqu'un qui vit isolé ou qui est moralement seul » ou comme la « Séparation d'un individu - ou d'un groupe d'individus - des autres membres de la société. » (2010, p.950).

L'isolement social se caractérise par une coupure avec la société. La vie en groupe est encore aisée les années qui suivent la mise à la pension car la santé, la mobilité et l'argent sont souvent encore présents. Cependant, au fil des ans, les capacités physiques, mentales, morales ou financières peuvent se détériorer. La coupure est rarement brusque, elle se produit petit à petit et elle n'est prise en compte que lorsqu'elle est déjà bien marquée. L'individu doit se déplacer dans la société mais lorsque les compétences ne sont plus là, peu de choses sont mises en place pour maintenir le lien. La société a muté dans sa mentalité mais aussi dans ses compétences à allonger l'espérance de vie. Notre société tient peu compte de cette partie vieillissante qui gagne en nombre (Mertens et al., 2020).

En ce qui concernent les origines de l'isolement social, elles peuvent être nombreuses et diverses.

Galdemar et Gilles indiquent que l'une des principales causes de l'isolement social est l'augmentation de la dépendance à un tiers qui peut être consécutive à une maladie, un accident

et l'avancée en âge. (2013). « Il désigne un processus inéluctable qui s'accompagne de pertes de capacités irréversibles. (...) les impacts de ces incapacités ont des conséquences plus ou moins fortes sur l'indépendance de la personne âgée et sur sa capacité à vivre de façon autonome dans son quotidien » (Galdemar et Gilles, 2013, p.17).

L'article « Solitude et vieillissement » mentionne aussi que

L'isolement est aussi la conséquence d'incapacités qui se cumulent : les difficultés de déplacement, mais aussi la perte de mémoire, la perte de l'ouïe ou de la vue creusent l'écart et rendent les contacts sociaux difficiles. (...) Les ressources économiques enfin sont déterminantes et entrent pour une large part dans l'isolement des personnes âgées, surtout si elles sont atteintes d'une maladie chronique (Van Rompaey, 2003, p. 4).

En outre, la précarité ne permet pas toujours l'accès aux aides médicales et sociales qui rendent possible le maintien à domicile (Pan ké Shon, 2003). De plus, les maisons de repos qui offrent un confort de vie optimal ainsi que des soins de qualité, ne sont pas toujours abordables financièrement. Jean-Louis Pan Ké Shon nuance la notion de précarité. Dans son article, il nuance la notion de précarité qui n'est pas seulement à concevoir comme un manque de moyens financiers. Être issu d'une minorité ethnique, de l'immigration, d'un niveau socio-culturel plus modeste et avoir un niveau d'étude plus faible, participe à plonger les individus dans cet isolement (2003).

On peut également observer une diminution des interactions sociales. Avec l'âge, il n'est pas aisé de faire ses courses. L'intérêt pour l'achat de vêtements est plus rudimentaire et le souci de prendre soin de soi peut également s'atténuer. Dépendre d'une tierce personne, qu'elle soit de la famille ou que l'on rétribue, est compliqué. La famille a ses propres préoccupations et le temps consacré est souvent concentré en un temps limité. On a peur de déranger et de solliciter de l'aide. Un étranger doit parfois être rémunéré et le manque d'argent peut être un frein (Van Rompaey, 2003).

De plus, on note une diminution des relations amicales, jusqu'à leur suppression. Le manque, la rupture dans les liens affectifs sont inévitables avec l'âge avançant. La mobilité, la dépendance et les soucis de santé fragilisent les individus. De plus, il est courant que la mort réduise le cercle amical et l'entrain à se créer de nouveaux amis est nettement moins présent pour les mêmes raisons (Mertens et al., 2020). « La perte d'autonomie, la limitation des déplacements et des activités réduit petit à petit le cercle des amis. Le fait d'assister à plus

d'enterrements que de mariages crée des coupes sombres dans les relations et isole petit à petit.
» (Martens et al., 2020, p.4).

Autre cause possible, une rupture avec le milieu familial qui se manifeste par l'absence des enfants dans les visites hebdomadaires et leurs interventions peuvent se cantonner aux décisions nécessaires aux aménagements mis en place (Van Rompaey, 2003). Christian Van Rompaey, dans son article paru dans le Cairn, indique, je cite : « Les liens familiaux restent le pivot du lien social » (2003, p.17). Ce pivot est parfois associé à un sentiment de devoir ou de contrainte. Pour fonctionner de façon saine, il est nécessaire que ces liens soient appliqués dans un esprit altruiste sans aspect économique. En somme, pour fonctionner, l'échange des rôles doit être nourri par la reconnaissance des enfants. Celle-ci dépend de l'investissement des parents par le passé (Van Rompaey, 2003).

Le veuvage ou le divorce seront les dernières origines citées. Ceux-ci sont propices à l'apparition d'un isolement social ou à un sentiment de solitude (Dayez, 2012). Cette solitude est fortement intériorisée et est très difficile à pallier. Jean-Baptiste Dayez mentionne que les femmes sont plus touchées par l'isolement. En effet, d'un point de vue des statistiques « En Belgique, 82% des veufs sont des personnes de plus de 65 ans (...) 81% sont des femmes. » (2012, p.2). Un conflit familial peut survenir à la suite du décès du conjoint ou à un changement dans la dynamique relationnelle avec les enfants. À chaque naissance ou décès, un nouvel équilibre se crée et les priorités se déplacent. La vieillesse associée à la maladie ou à la perte d'autonomie peut déclencher des conflits qui amènent à des éloignements soit physiques, soit affectifs (Mertens et al., 2020).

Le sentiment de solitude en est une conséquence comme dit précédemment et est défini par Pascal et Frécon Valentin comme une « vulnérabilité à un sentiment de mal-être associé au désir ou au besoin de plus de contacts avec les autres qui peut compromettre la santé. » (2017, p.410). Au sens littéral, « Le Robert » définit la solitude comme la « Situation d'une personne qui est seule » (2019, p.1816). Comme mentionné précédemment, « Le Petit Larousse », ajoute une dimension morale à ce concept d'isolement social. Ces deux aspects d'un même concept sont souvent présentés comme liés. Toutefois, elles sont différentes et l'apparition de l'une ne sous-entend pas d'emblée l'apparition de l'autre. Cette distinction est évoquée par Jean-Baptiste Dayez sous une dimension psycho-sociale dans un article publié pour la Mutualité Chrétienne. Il est important de dissocier l'isolement et le sentiment de solitude. En effet, il définit l'isolement social sous une dimension plus objectivable : « L'isolement social est

mesurable objectivement sur base du nombre de contacts sociaux qu'une personne a dans sa vie quotidienne (...) L'isolement social peut être ou ne pas être source de solitude. » (2012, p.1-2). En l'occurrence, la solitude est un signe révélateur de l'isolement mais à contrario, l'absence du sentiment de solitude n'exclut pas une réalité d'isolement. Il nous apparaît dès lors que ce concept peut être défini non seulement sous un aspect médical mais également sous un aspect psycho-social. Le médical et le psycho-social sont les deux versants qui caractérisent le métier d'infirmier(ère). En outre, une étude territoriale française menée par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) permet de quantifier cet isolement par le fait que les personnes qui ont moins de quatre contacts d'ordre privé au cours d'une semaine, sont considérées comme isolées (Pan Ké Shon, 2003). « [Cependant, il peut être] recherché, car il peut être source de créativité, facilitant la concentration et les apprentissages (Luanaigh & Lawlor, 2008 cités par Dayez, 2012, p.1). Ce sentiment peut ou ne pas apparaître car il est en corrélation directe avec la personnalité de chaque individu. Dans l'ouvrage « Solitude et isolement des personnes âgées », « l'importance de la personnalité de l'individu, qui a une influence sur la façon dont chacun appréhende les choses. » (Pitaud, 2020, p.71). J'ai pu l'observer au cours de la seconde situation. La patiente a réussi à puiser dans ses ressources afin de surmonter les difficultés émotionnelles liées à son déracinement. La dimension psycho-sociale met en avant la personnalité des individus comme un levier qui leur permet de passer outre des chamboulements liés au nouveau cadre de vie.

D'autres conséquences peuvent être observées comme le stress, les troubles cognitifs, l'altération de la santé mentale, l'altération de la santé, l'apparition de maladies chroniques et l'apparition du « syndrome de glissement » (Van Rompaey, 2003, p.12). En effet, Hélène Eraly précise que cet isolement peut influencer la qualité d'une santé qui peut être bonne à la base. Il peut altérer la santé mentale qui peut mener au pire des cas, à des suicides. On peut relever aussi, des troubles du sommeil, des problèmes cardio-vasculaires et de l'hypertension. De plus, elle peut être un facteur de morbidité (2020).

Nous pouvons illustrer les concepts développés ci-dessus au travers des deux situations de stages vécues.

Madame D présentait une incapacité à entrer en communication et un trouble de la parole, à la suite d'un AVC. Cette incapacité permanente rendait les échanges au quotidien laborieux. Dès lors, un repli sur soi s'est observé et un découragement s'est installé. En conséquence, une coupure dans les liens sociaux a conduit à un isolement.

Au cours de mon second stage, la pandémie du Covid-19 est survenue. En quelques semaines, des mesures imposées pour la sauvegarde de la santé commune a pris le pas sur toutes notions de bien-être et de santé mentale. Ces mesures ont provoqué un isolement social à la suite d'une altération de la communication qui s'est généralisé dans toutes les couches de la société. Un sentiment de solitude exacerbé est apparu dans les maisons de repos.

En conclusion, il faut tenir compte de l'existence d'un tronc commun à tous les actes professionnels posés par les infirmières. Toutefois, en fonction du milieu, une prévalence de l'aspect médical ou du psycho-social se fait ressentir. En effet, une infirmière en MRS se doit d'apporter une dimension psycho-sociale à son travail car le séjour est rarement transitoire et l'équipe encadrante fait partie du cadre de vie des résidents.

A l'issue du développement des différents concepts, nous pouvons déjà poser le postulat suivant, l'altération de la communication et l'isolement social sont tous deux intimement liés et présents dans ce type de population.

2.2. Analyse de l'entretien exploratoire

L'opportunité de s'entretenir avec une professionnelle de terrain a été un moment particulier pour moi. Il m'a permis de confronter certaines croyances qui ont émergé au cours de mes différents stages durant ce cursus. J'ai pu également constater s'il existe une grande différence entre la théorie qui est la base de ma pratique actuelle et la réalité de terrain qui est le quotidien de la personne interrogée.

Mon choix s'est porté sur une infirmière en cheffe travaillant dans une MRS en Belgique. Cette interlocutrice était pertinente tant d'un point de vue de l'expérience que du point de vue du sujet de ce TFE. Il m'a été possible de lui faire part des concepts et des interrogations qui ont été traités dans ce travail et de recueillir son opinion de personne de terrain. L'interview a été axée sur les thèmes développés tout au long de ce travail, en l'occurrence, l'altération de la communication, l'isolement social et le sentiment de solitude.

Mon questionnaire a débuté par un descriptif du parcours professionnel et les raisons du choix de Madame A, l'infirmière en cheffe, à rester dans ce secteur. La majeure partie de sa carrière professionnelle s'est déroulée dans le cadre des soins à domicile et en maison de repos, pendant plus de 28 ans. Elle a fait une brève incursion en consultation gynécologique et a effectué une formation en sénologie. Lorsque l'on aborde la question du pourquoi de ce secteur, Madame A a mentionné son attrait pour l'aspect relationnel qui est prépondérant avec ce type de population

mais également son intérêt pour le médical. La diversité des pathologies ainsi que l'analyse de situations médicales complexes, sont plus récurrentes chez les personnes âgées. Il est rare de ne rencontrer qu'une seule pathologie à la fois : la vieillesse est source de nombreux dysfonctionnements. Les relations se vivent et se déroulent sur plusieurs années, nous partageons le quotidien et un lieu de vie. De plus, les médecins traitants ont une meilleure conscience du rôle prépondérant de l'infirmière. En effet, la collaboration entre infirmières et médecins se base sur un suivi continu et sur du long terme. Selon Madame A, l'envie de travailler avec la personne âgée est la condition principale à ce choix de secteur. Bien que toute infirmière soit apte de par sa formation à professer en MRS, il est nécessaire de posséder certaines qualités telles que la patience et l'empathie sont indispensables.

Selon les intervenants rencontrés en maison de repos et la diversité de population qui séjourne dans ces résidences, Madame A a été amenée à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Chaque discipline travaille à tour de rôle auprès des patients en fonction de leurs besoins. Dans son lieu de travail, cette équipe se compose de kinésithérapeutes, de logopèdes, d'éducatrices, d'infirmières, d'aides-soignantes et des médecins coordinateurs. Lors des réunions, un représentant de chaque pôle est présent afin de discuter des patients. Ils ont également des intervenants externes tels que des psychologues ou des kinésithérapeutes indépendants.

Une personne est considérée comme âgée à partir de 65 ans. Madame A a côtoyé un échantillon assez large. Des couples, des personnes seules, des centenaires, des personnes ayant eu un AVC et de plus en plus fréquemment, des parkinsoniens « jeunes ». Il y a un pourcentage plus élevé de femmes que d'hommes et cela a été mentionné dans les antécédents du concept d'isolement social.

La plupart des résidents vivent au sein de l'institution pour une période indéterminée. Toutefois, il existe des séjours de transition et des courts séjours. Il est agréable de constater à l'issue de ces courts séjours que les moyens mis en œuvre, ont permis de rétablir une autonomie. Néanmoins, le bonheur du retour à domicile est teinté d'une angoisse générée par le fait de quitter le cocon sécurisant que constitue l'institution. L'accès au soin et la rapidité de la prise en charge en cas de problème sont rassurants pour les résidents. L'une des conséquences de la Covid-19 est que les nouveaux occupants attendent d'être lourdement impactés dans leur autonomie avant d'entrer en maison de repos. En effet, par peur d'être confiné et de ne plus voir leurs proches, ils viennent avec des invalidités plus avancées et ce sont des cas plus lourds.

Si l'on se réfère à notre premier concept, il est intéressant de s'interroger sur les outils utilisés pour palier à l'altération de la communication et plus précisément au trouble du langage. L'institution avait mis en place certains outils et fonctionnait au cas par cas. En l'occurrence, deux cas de figures ont été rencontrés. Dans le cas d'une difficulté à s'exprimer, un tableau tactile a été utilisé. L'écrit est également un moyen de compensation. Il est évident que le patient doit être apte à utiliser l'outil avant toute mise en pratique. En outre, en cas de démence, l'utilisation reste très difficile, le niveau de compréhension est impacté. Des moyens plus empiriques sont dès lors utilisés, tels que le geste, notre parole, le regard et l'accompagnement. À l'heure actuelle la tablette est pratique car on peut y installer des applications. D'autre part, la coupure de la communication avec les proches lors du premier confinement a marqué les esprits. Les moyens mis en place pour maintenir les liens avec les proches comme le plexi, la visioconférence, le masque etc... n'ont pas été efficaces pour les personnes âgées. Une personne atteinte d'Alzheimer n'avait pas la possibilité de comprendre la situation d'urgence ni d'accepter le manque physique qu'aucun outil ne pouvait compenser. Selon Madame A, l'AVC est la pathologie la plus invalidante pour la communication orale ou écrite. En effet, les conséquences sont aussi physiques que neurologiques. La maladie d'Alzheimer n'a pas d'incidence immédiate sur la mobilité mais sur les connexions neuronales et cela influe sur l'efficacité de la communication. Le parkinson n'a pas d'effet immédiat sur le langage mais à long terme, il rend le langage incompréhensible et les relations sociales compliquées. L'incapacité à maîtriser sa motricité ne permet plus d'interaction directe avec ses pairs. Les personnes ne mangent plus seules et ne veulent donc pas manger au réfectoire. Elles ne participent plus aux jeux de société car cela nécessite l'aide d'une tierce personne. Elles ont donc tendance à s'exclure d'elles-mêmes. L'ensemble de ces pathologies ont des conséquences néfastes sur les relations sociales en général.

En ce qui concerne les résidents qui réclament de l'attention relationnelle et pour faire face aux problématiques de l'isolement social ainsi que du sentiment de solitude, Madame A a été amenée à réaliser une anamnèse qui permet de sélectionner les activités ou les ressources les plus adéquates. Il n'est pas judicieux de proposer des nouveautés qui peuvent être déstabilisantes. Il est important de créer une continuité à ce qui existait déjà dans leur quotidien lorsqu'ils étaient à domicile. Par exemple, si la patiente aimait converser avec sa voisine ils essayaient de recréer ce type de situation dans la maison de repos. Cependant, il faut accompagner le résident dans les propositions qui lui sont faites. Le manque de temps se fait ressentir surtout dans les cas où l'autonomie est touchée, ils ne peuvent pas toujours

accompagner les personnes dans leurs activités. Paradoxalement, le temps consacré n'est pas suffisant mais quelle que soit le temps alloué, il n'est pas toujours aisé d'être en phase avec les disponibilités et les besoins immédiats des résidents. De plus, ce sentiment de solitude peut apparaître à différents moments de la journée. Il est également nécessaire d'entendre que certains résidents ne sont pas demandeurs ou que d'autres ne pourront jamais être satisfaits.

L'importance des visites a aussi été abordée. Madame A a expliqué qu'il est extrêmement rare qu'un résident ne bénéficie pas de visites de proches. La fréquence est variable et est souvent conditionnée par la distance géographique ainsi que par la charge de travail des enfants ou des personnes apparentées. Les résidents manifestent plus de joie à une sortie ou à une rencontre avec la famille dont la visite est peu régulière. Certaines personnes ont la chance d'avoir des visites hebdomadaires, ils les ont intégrées dans leur quotidien et les considèrent comme habituelles. À contrario, les personnes peu visitées l'ont également été dans leur vie à domicile. De ce fait, ils ne s'en plaignent pas. La qualité de la relation parents/enfants détermine aussi la fréquence de ces visites. Certaines pathologies, comme Alzheimer, peuvent influencer négativement les visites et/ou leur fréquence. La famille peut être déçue à l'issue des visites lorsque la personne ne les reconnaît pas, ne se souvient pas ou qu'elle manifeste de l'agressivité car elle ne comprend pas la situation. L'effet peut être destructeur pour la relation et pour la famille. Selon Madame A : « On ne peut pas juger la qualité et la quantité des visites ». De part cette phrase, Madame A a exprimé l'inutilité de juger de la qualité du soutien familial par le degré de fréquence car il y a tellement de paramètres qui peuvent la déterminer. C'est du cas par cas. Certains couples, du fait de la perte d'autonomie, sont amenés à vivre séparément. À fortiori, un conjoint va rendre des visites plus fréquentes qu'un enfant.

Quels sont les marqueurs qui déterminent un isolement social ou un sentiment de solitude ? Quelles sont les manifestations qui doivent alerter le personnel de première ligne ? Madame A est attentive aux larmes, aux plaintes, aux expressions faciales, aux démonstrations du mal-être et au syndrome de glissement. Cependant, il faut également tenir compte que ces symptômes peuvent être le résultat d'un refus de placement. Nous avons donc bien conscience qu'il y a une part d'interprétation de la personne soignante qui les a observés. Le personnel soignant a conscience contrairement au tout-venant qu'il y a un travail à effectuer en amont. En effet, le placement est encore un sujet tabou. La personne âgée est parfois contrainte par les circonstances et elle entre en institution avec un sentiment de révolte qui est souvent à l'origine de ce sentiment de solitude. J'ai donc interrogé Madame A quant à la personne à l'origine du

placement. Qui décide ? Il peut s'agir d'un conjoint épuisé, des enfants, du médecin traitant ou à une situation dont la conséquence est une perte d'autonomie passagère ou définitive. Le patient est-il consulté ? Dans la pratique de Madame A, le patient n'est informé de cet aménagement que suite à la décision prise par un tiers. Néanmoins, dans de très rare cas, il peut arriver que la décision vienne de la personne elle-même. Dans ce cas, l'acceptation au préalable aide à mieux vivre la situation et à ne pas en retenir que les points négatifs. L'image de l'institution est sociétaire et générationnelle, elle est souvent synonyme de mouvoir, d'hospice et de négativisme, ce qui n'est plus d'actualité en général.

La charge émotionnelle qui se répercute sur le personnel soignant face à l'isolement et le sentiment de solitude, est-elle importante ? Selon Madame A, « on ne se donne jamais le droit de juger une famille. Ça c'est une certitude ! ». En tant que cheffe, il est important pour elle de rappeler régulièrement à l'équipe que quel que soit l'état de tristesse du résident et l'impact logique que cela peut susciter en nous, notre accompagnement doit rester professionnel. Il est inévitable que des affinités se créent, cela reste humain mais nous ne pouvons jamais franchir le pas de se substituer à la famille. Cela est la garantie que notre intervention reste dans un cadre de soignant. Trouver le juste milieu est un travail qui se fait au quotidien et nous restons des êtres humains donc sensibles.

In fine, j'ai conscience qu'il ne faut pas généraliser et enfermer le résident dans des idées préconçues. Chaque résident a son vécu, sa pathologie et sa réalité familiale. Rien n'est figé, notre adéquation réside dans notre suivi sur du long terme et notre capacité à être attentif aux signaux qu'ils vont émettre consciemment ou inconsciemment.

2.3. Recherche et analyse d'un article probant

Dès le départ de la rédaction de ce travail, ma recherche s'est concentrée sur des articles scientifiques ayant pour objectif de démontrer l'existence de l'isolement social et pouvoir le mettre en lien causal avec l'altération de la communication. Quel que soit le canal de recherche utilisé, Google, Google Scholar, PubMed, bibliothèques de la HERS et à Marche-en-Famenne, aucun n'a abouti. Il a donc été nécessaire de redéfinir mon questionnement initial. En l'occurrence, axer ce questionnement sur des articles qui parleraient de solutions afin de palier à l'isolement social et/ou à l'altération de la communication des personnes âgées. La recherche via Google, m'a permis de trouver l'article probant suivant : « Isolement social et solitude : les nouveaux géants gériatriques » par Amy Freedman et Jennifer Nicolle. Cet article est une méta-

synthèse dont la visée est plus qualitative que quantitative. Les auteurs mettent également en évidence le manque de rigueur scientifique des études méta-analytiques existantes.

La population ciblée sont « les personnes âgées de plus de 65 ans ». Les documents utilisés proviennent principalement du Canada, des États-Unis, du Royaume-Unis et de la Hollande. L'objectif de l'article est de mettre en évidence les problèmes générés par l'isolement social, par la solitude chez les personnes âgées et par les risques associés. Des pistes d'interventions sont évoquées mais aucun protocole efficace et défini n'a pu être établi clairement. Les auteurs précisent que cet article ne doit pas être pris comme un recueil exhaustif et qu'il ne contient pas de données quantitatives significatives du secteur investigué.

Selon les auteurs, cette problématique est aussi importante que les causes connues telles que le tabagisme ou la démence. Cependant, elle n'est pas encore reconnue au même titre. De ce fait, l'identification et la prise en charge par les acteurs de terrain de première ligne, sont difficiles. Plusieurs pistes dont l'échelle de la solitude en trois points, ont été présentées dans leur article.

Le médecin traitant serait l'un des intervenants des soins primaires, le plus susceptible de déterminer une situation d'isolement ou de sentiment de solitude. Toutefois, bien que le médecin ait la possibilité de reconnaître les marqueurs, la prise en charge est difficile car il y a très peu de solutions à proposer pour y pallier. Une certaine réticence dans l'identification de ces nouveaux géants gériatriques potentiels, s'est manifestée lors des études menées en Hollande.

Il a été évoqué dans le second concept que l'isolement social était un facteur favorisant de morbidité. Cette notion est évoquée par les auteurs « la solitude et l'isolement social sont liés à un risque plus élevé de mortalité de 26% et 29% respectivement ... les personnes esseulées ou socialement isolées ont un risque accru de problèmes physiques et mentaux et utilisent davantage les services de santé » (Freedman et Nicolle, 2020, p.80).

Dans le premier concept, les déficits sensoriels sont mentionnés dans les caractéristiques de l'altération de la communication, ils sont repris par les auteurs dans les facteurs de risque de l'isolement social, leur réadaptation permet d'amoindrir la solitude et de façon indirecte, l'isolement social.

« L'accès à des moyens de transport fiables et abordables est souvent une condition préalable essentielle pour que les adultes plus âgés demeurent engagés dans la communauté et

maintiennent leurs relations » (Freedman et Nicolle, 2020, p.82). Nous avons mentionné l'importance de la mobilité comme moyen de lutter contre l'isolement au travers de l'article 4-8 de la Charte Européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées ainsi que dans le second concept.

Les coûts peuvent être un obstacle à la participation à des programmes sociaux. Il faudrait encourager les aînés à faire leur déclaration de revenus, car il existe des avantages gouvernementaux pour les personnes âgées à faible revenu. Certains programmes abolissent les frais ou utilisent un barème dégressif pour les aînés à faible revenu (Freedman et Nicolle, 2020, p.83).

Cette précarité financière qui est un frein à l'accès aux aides luttant contre l'isolement, nous l'avons également mentionnée lors de notre premier concept. Cependant, cette précarité n'est pas uniquement financière, elle est aussi sociétale, intellectuelle ou émotionnelle. Freedman et Nicolle l'abordent sans la nommer lorsqu'ils mentionnent les difficultés rencontrées par les immigrés de première génération ou les personnes LGBTQ+ lorsqu'il s'agit d'accéder à ces aides.

Il existe des interventions mises en pratique sur le terrain, ces interventions sont souvent l'œuvre de communautés isolées et il a été mis en avant lors des recherches effectuées par Freedman et Nicolle qu'il n'est pas possible de déterminer de façon probante les interventions qui sont efficaces sur un grand nombre. Il n'y a pas un recul suffisant pour attester d'un bienfait avéré sur la santé des sujets. Il n'a pas été possible de retirer un échantillon des interventions les plus efficaces car cette problématique n'en est qu'à ses prémises. Toutefois, la technologie semblerait être un facteur d'atténuation car elle faciliterait le maintien des liens avec la famille, les amis. Comme le souligne Madame A, au sein de l'enquête exploratoire, quelles que soient les interventions mises en œuvre pour combattre isolement et solitude, il est nécessaire d'adopter une approche individuelle et basée sur les habitudes passées du résident. Cette façon de procéder est également mentionnée par Freedman et Nicolle

Étant donné l'absence de lignes directrices claires concernant les interventions efficaces adaptées à la personne, ainsi que la diversité des besoins et des préférences des adultes plus âgés, nous conseillons aux cliniciens d'utiliser une approche individualisée et centrée sur le patient pour aborder l'isolement social et la solitude (Freedman et Nicolle, 2020, p.82).

L'article probant de Freedman et Nicolle stipule qu'en 1965, l'expression les géants gériatriques a été inventée par le Professeur Bernard Isaacs. Cette expression incluait quatre domaines « immobilité, instabilité, incontinence et déficience dans l'intellect ou la mémoire » provoquant maladie et souffrance aux personnes âgées. L'évolution de notre société a créé de nouveaux domaines potentiels dont l'impact sur la population a été abordé dans ce travail (2020).

A l'issue de cette quête tant théorique que pratique, la communication me semble être une dimension essentielle. En effet, qu'elle soit efficiente ou déficiente, elle est un acteur dont il faut tenir compte dans une population de type personnes âgées. L'avancée dans l'âge, la perte lente ou rapide de ses pairs, l'apparition de pathologies liées à l'âge et la perte éventuelle d'autonomie, sont des signes qui peuvent nous alerter quant à l'apparition de l'isolement et/ou de la solitude. La communication reste un moyen de les freiner.

Outre le fait que l'on fasse partie d'un groupe servant de base à des statistiques, la personne âgée est avant tout un être unique et à part entière. La solution la plus adéquate serait de traiter chaque situation au cas par cas. Cependant, nous ne pouvons faire abstraction du groupe dont la dynamique peut être aussi un moteur.

Il est évident que la vieillesse et tous les nouveaux concepts qui en découlent, sont observés mais sont encore en voie de réflexion et encore peu pris en compte. Une certaine impuissance a émané des écrits qui ont été consultés.

3. Synthèse, questionnement professionnel et pistes de réflexion

Mon stage de seconde année en MRS est à l'origine du constat suivant. J'ai pu observer, sans possibilité d'y remédier, un isolement social mis en évidence par la Covid-19. J'ai mis en corrélation cette situation avec celle vécue précédemment lors de mon premier stage. La situation de la covid-19 a provoqué une coupure de communication entre les personnes institutionnalisées et le monde extérieur. A contrario, les patients présentant un trouble de la communication, telle que la personne rencontrée dans mon premier constat, présentent une pathologie qui pourrait les couper des autres.

Les recherches de départ m'ont permis de mettre en avant l'existence de lois et de chartes qui régissent le fonctionnement d'une MRS. Dans un souci de protection de la société à l'encontre d'une partie de sa population dite fragile, il est rassurant de constater que leur bien-être et leur mobilité sont des préoccupations essentielles. Toutefois, malgré la bonne volonté de tous, si l'objectif est de mettre en pratique ces préceptes, la réalité est plus complexe. De cette recherche, a émergé deux concepts de base ; l'altération de la communication et l'isolement social. Ces concepts sont en lien direct, ils peuvent être consécutifs ou exister l'un sans l'autre et déboucher tous deux sur un sentiment de solitude. Cet isolement provoque troubles mentaux, maladies cardiaques, altération de la santé, altération de la santé mentale, apparition de maladies chroniques, augmentation du risque de suicide, apparition du syndrome de glissement et troubles du sommeil pour ne citer que ceux-ci.

Les points essentiels à retenir de l'entretien avec Madame A, sont l'importance de traiter les résidents au cas par cas, de proposer un accompagnement par les gestes ainsi que par le regard et le toucher. Il est primordial que la vie en MRS soit le plus possible similaire à la vie à domicile. L'acceptation est un aspect essentiel à obtenir car il impacte la qualité de vie. Néanmoins, il n'est pas automatique et dépend de la situation propre à chaque résident. Il est important de prendre du recul face à notre propre interprétation d'une situation. Nous devons être attentifs à ne pas projeter notre propre ressenti. Il est difficile de solutionner des troubles de la communication dans une population comme les personnes âgées car il y a rarement des pathologies isolées. En outre, la solitude est un sentiment subjectif. Il peut être une interprétation du personnel encadrant lorsque le patient présente un trouble de la communication et est dans l'incapacité d'effectuer des demandes claires.

L'article scientifique nous conforte quant à l'idée que cette problématique est bien réelle mais que nous sommes encore peu outillés pour y faire face. Cela m'a rassurée car il a été très

difficile de trouver des données scientifiques pour étayer le lien entre ces deux concepts. Cet article montre que l'isolement social est l'une des causes de mortalité des personnes âgées.

Les différentes lectures sur lesquelles s'appuient ce TFE met en avant une problématique qui interpelle depuis les années 2000. Cette problématique que je pensais récente et consécutive à un événement extraordinaire, se révèle être un fait bien connu mais dont le sujet d'étude est récent et dont les moyens d'y remédier ne sont pas encore définis. Des pistes sont évoquées mais elles ne sont pas encore validées par des études qui répondent à tous les critères scientifiques.

Mes questionnements de départ sont les suivants : face aux situations vécues lors de mes stages et en tant que future infirmière, quels sont les moyens dont je dispose, que puis-je mettre en place et quelles sont les limites de mon champ d'action ? À l'issue des recherches effectuées et des réflexions qui étayent ce travail, il n'existe pas vraiment de solution de référence que l'on peut utiliser en tant qu'infirmière. Notre intervention consiste à accompagner et à créer une relation de confiance tout en gardant une distance professionnelle. Les troubles de la communication sont un frein réel quant à la possibilité de solutionner l'isolement social et le sentiment de solitude. L'entretien avec Madame A, m'a permis de prendre conscience que nous arrivons à un moment donné d'une vie. Notre mission est d'accompagner la personne qui peut être en souffrance. Et je pourrai dorénavant mieux appréhender une situation similaire à celle vécue avec Madame D.

Un questionnement professionnel en a découlé : pour quelle(s) raison(s) certaines personnes âgées se sentent-elles plus isolées en institution ? De nombreux facteurs sont apparus tels que la pathologie, la mobilité, la communication, la relation interfamiliale, le veuvage, l'acceptation de l'entrée en institution, le caractère propre à chacun etc.

L'acceptation me semble être le seul facteur sur lequel nous pouvons avoir une incidence. En effet, l'isolement social est un sujet tabou et la maison de repos en est parfois la représentation négative. Les personnes âgées ont un déni de cette vieillesse et de ses conséquences. Allonger la vie, avoir le pouvoir de reculer l'heure de notre mort ne sont pas toujours associés à tous les aspects négatifs qui peuvent en découler. De ce questionnement, a émané d'autres interrogations et des nouvelles pistes de réflexion. Pour quelles raisons les personnes âgées ne sont-elles pas prêtes à accepter psychologiquement cette réalité ? Un déni de vieillesse, par les personnes concernées, par la famille et par la société, quelle en est l'origine ? Est-ce sociétaire

ou culturel ? Comment sensibiliser les gens pour qu'ils entrent dans un processus d'acceptation et de réflexion pour des pistes de solution éventuelles ?

Une piste de solution que je souhaite introduire est la prévention. D'un point de vue légal, 65 ans est l'âge de l'entrée dans la vieillesse. Ne serait-il pas judicieux d'accompagner ce passage par de la prévention ? Le médecin traitant ou tout personnel soignant de première ligne, pourrait sensibiliser les personnes âgées ainsi que leurs entourages aux problèmes liés à la vieillesse. Cette problématique devrait être envisagée comme d'autres thématiques qui bénéficient de campagne de sensibilisation. Réfléchissons au bien vieillir ! Comme souligné dans l'article scientifique probant, nous pourrions aller plus loin que l'identification de l'isolement et de la solitude. Un rôle déterminant dans une aide précoce et une approche valable face à ce nouveau défi qu'est la prise en charge de cette population vieillissante. Cela pourrait éviter certaines prises de décision à la hâte et influencer positivement sur ces transitions de vie. L'objectif serait de s'extraire de la pensée que parler d'un sujet, crée inévitablement une réalité. De plus, au-delà de la prévention, la possibilité d'offrir une prise en charge plus humaine, nécessiterait un personnel plus nombreux, plus de moyens mis à la disposition de cette partie de la population.

Conclusion personnelle

Au terme de la rédaction de ce travail, poser un regard critique sur celui-ci n'est pas évident. Dès le départ, j'avais conscience d'aborder un sujet vaste mais également très difficile à circonscrire. En effet, cette problématique est récente et il existe trop peu d'articles scientifiques pour pouvoir l'étayer aussi complètement que souhaité. Mon anglais approximatif ne m'a pas permis d'accéder à des articles anglophones. Ce regard plus international aurait pu m'apporter un éclairage plus étoffé et plus diversifié.

Bien que riche d'un point de vue pratique, il faut tenir compte du fait que la maison de repos dans laquelle travaille la personne interrogée, n'est pas représentative de l'ensemble des institutions.

Dans un souci de ne pas se disperser et de maintenir une base rigoureuse, il me paraît important de ne pas mentionner d'autres canaux de transmission tels que les publicités, les revues périodiques et les folders qui traitent du sujet.

À titre personnel, ce TFE m'a permis de sensibiliser les membres de ma famille à cette réalité future que sont l'acceptation de la vieillesse et la possibilité d'entrer en maison de repos. La génération de ma grand-mère est plus fermée et susceptible face à ce sujet délicat. Ouvrir la discussion est devenu une réalité.

Professionnellement, j'ai conscience que l'aspect technique répond plus à mon souhait de développement sur du long terme. Toutefois, le relationnel fait partie intégrante du type de prise en charge que je souhaite appliquer dans le futur lorsque je serai diplômée. Je veillerai à ce que cet aspect relationnel soit toujours empreint de bienveillance et d'empathie.

Il me paraît indéniable que je serai en contact avec des personnes âgées, quel que soit le secteur. Dès lors, je pourrais faire partie de ces soignants de première ligne qui peuvent œuvrer à sensibiliser la population.

Il faut néanmoins souligner l'importance de garder une distance professionnelle. Toute implication doit respecter un cadre pour préserver une charge émotionnelle viable et saine. Il est également vital d'être à l'écoute des besoins réels des patients car chaque individu est unique.

Liste de références

- Aubin, M., Giguère, A., Hadjistavropoulos, T. et Verreault, R. (2007). L'évaluation systématique des instruments pour la douleur chez les personnes âgées ayant des capacités réduites à communiquer. *Pain Res Manag*, 12(3). 195- 203. Récupéré de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2670710/>
- Bay, C., Dancot, J., Jacquemin, N., Lebas, M-C., Maucq, S., Pirson, A. et Tison, T. (année). Référentiel de compétence : Baccalauréat infirmier responsable de soins généraux (BIRSG). Document non publié, Haute Ecole Robert Schuman, Libramont, Belgique. Consulté le 10 octobre 2021.
- Castex, A. et Comte, M. (2019). AVC, rééducation en soins de suite et de réadaptation. *Soins gériatrie*, 138. 23.
- Cosnier, J. (1977). Communication non verbale et langage. *Psychologie médicale*, 9,11. 2033 – 2049. Récupéré de http://www.icar.cnrs.fr/pageperso/jcosnier/articles/II-1_Com_Non_Verbale.pdf
- Covelet, R. (2007). Prendre enfin conscience des enjeux des déficits sensoriels des personnes âgées. *Gérontologie et société*, 30 n°123. 249 à 262. Récupéré de <https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2007-4-page-249.htm> (Covelet)
- Cudennec, T. (2019). Les accidents vasculaires cérébraux. *Soins gériatrie*, 138. p.9.
- Dayez, J-B. (2012). L'isolement social et le sentiment de solitude des aînés : précisions et pistes d'intervention. *Études mouvement social des aînés*. Récupéré de https://www.academia.edu/27068789/L_isolement_social_et_le_sentiment_de_solitude_des_aînés_précisions_et_pistes_d_intervention
- DeVito, J., Chassé, G. et Vezeau, C. (2019). La communication interpersonnelle. *Pearson ERPI*. Récupéré de https://www.pearsonerpi.com/uploads/pdf_extracts/communication-interpersonnelle-4e-manuel-extrait.pdf
- Freedman, A. et Nicolle, J. (2020). Isolement social et solitude : les nouveaux géants gériatriques. *Le Médecin de famille canadien*, 66. p.78- 85. Récupéré de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8302349/pdf/066e78.pdf>

- Galdemar, V. et Gilles, L. (2013). Étude qualitative des effets de l'intervention bénévole sur l'isolement et la perte d'autonomie des personnes âgées. *Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC)*. Récupéré de <https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2013-4066.pdf>
- Haute Autorité de Santé [HAS]. (2018). Communiquer malgré les troubles de la mémoire ou du langage. *Parcours de coins des patients présentant un trouble neurocognitif associé à la maladie d'Alzheimer ou à une maladie apparentée*. Récupéré de https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-05/fiche_14_communiquer_troubles_memoire_langage.pdf
- Hazif-Thomas, C. (2014). Santé mentale et solitude dans l'âge avancé. *Soins gériatrie, 105*. p.17.
- Lamirand, C. (2010). Évaluer la douleur des personnes âgées non communicantes. *Soins gériatrie, 81*. p. 5.
- Larousse. (2002). Altération – Trouble. Dans le *Dictionnaire des synonyme Larousse*.
- Larousse. (2010). Communication, Isolement. Dans le *Petit Larousse Illustré*.
- Larousse. (2011). Communication. Dans le *Dictionnaire de poche Larousse*.
- Le centre interfédéral pour l'égalité des chances - Unia. (2021). *L'impact des mesures Covid-19 sur les droits humains dans les maisons de repos (et de soins) : une étude qualitative*. Récupéré de https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Rapport_Covid_MRS-FR_def_Print.pdf
- Le Robert. (2019). Solitude. Dans le dictionnaire *Le Robert illustré*.
- Le Robert. (2020). Altération. Dans *Le Robert illustré*.
- Mertens S., Eraly H., Brard C., Andrianne P., Solar L. et Wathélet V. (2020) Solitude et isolement : Parlons-en ! *BALISES journal des cadre d'énéo, mouvement social des ainés*. 70, 1 – 27. Récupéré de <https://www.eneo.be/publications/balises-n70-solitude-et-isolement-parlons-en/>

- Mias, L. (2003). *Personne âgées et besoin de communiquer*. Récupéré de <http://papidoc.chic-cm.fr/573Hend10Communiquer.pdf>
- Organisation Mondiale de la Santé [OMS]. (2021). Démence. Récupéré de <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/dementia>. Consulté le 13 avril 2022.
- Pan Ké Shon, J-L. (2003). Isolement relationnel et mal-être. *INSEE Première*, 931. Récupéré de <http://jechantesouvent.free.fr/IMG/pdf/ip931.pdf>
- Parlement Wallon. (2009). Décret relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées. Récupéré de <https://wallex.wallonie.be/contents/acts/7/7580/1.html?doc=14999&rev=16375-9666>
- Pascal, A. et Frécon Valentin, E. (2015 – 2017). *Diagnostics infirmiers, interventions et résultats*.
- Pitaud, P. (2020). *Solitude et isolement des personnes âgées*.
- Renault, J. (2014-2017). *Psychologie de la relation*. Syllabus, Haute École Robert Schuman, Libramont, Belgique.
- Tran, T-M., Dassé, P., Letellier, L., Ljubinkovic, C., Théry, J. et Mackowiak, M-A. (2012). *Les troubles du langage inauguraux et démence : étude des troubles lexicaux auprès de 28 patients au stade débutant de la maladie d'Alzheimer*. Récupéré de https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2012/01/shsconf_cmlf12_000211.pdf
- Union Européenne. (2010). *Charte européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées nécessitant des soins et une assistance de longue durée*. Récupéré de https://www.age-platform.eu/sites/default/files/European%20Charter_FR.pdf
- Van Rompaey C. (2003). Solitude et vieillissement. *Pensée plurielle*. 2 (6). 31 – 40. Récupéré de <https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2003-2-page-31.htm>
- Varel. (1977). Communication. Dans le *Dictionnaire de psychologie*.

Année académique 2021-2022

Je soussigné SIMON Margot autorise les membres de la Cellule d'Encadrement Méthodologique des Travaux de Fin d'Études à utiliser la version électronique de mon Travail de Fin d'Études et ce à des fins pédagogiques.

Date et signature(s) (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Le 25/05/2022
Lu et approuvé 